Test

Niveau : DES
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Test

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

L'épidémiologie, discipline fondamentale de la santé publique, est l'étude de la distribution et des déterminants des états ou événements liés à la santé dans des populations spécifiques, et l'application de cette étude au contrôle des problèmes de santé (Alikhan et Hocker, 2022). En dermatologie, la compréhension des principes épidémiologiques est essentielle pour appréhender la charge des maladies cutanées, identifier les facteurs de risque, évaluer l'efficacité des interventions diagnostiques et thérapeutiques, et orienter les stratégies de prévention et de santé publique. Ce cours vise à fournir une base solide des concepts épidémiologiques et biostatistiques indispensables à la pratique et à la recherche en dermatologie de niveau DES.

Principes Fondamentaux de l'

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome

La présentation clinique du mélanome est polymorphe et varie considérablement en fonction du sous-type histologique, de son stade évolutif et de sa localisation anatomique. Une reconnaissance précoce est cruciale pour un pronostic favorable, bien que la sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés soit estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025). L'intégration de l'anamnèse, de l'examen clinique macroscopique et de la dermatoscopie est indispensable pour optimiser la précision diagnostique.

Caractéristiques Cliniques Macroscopiques

La détection clinique du mélanome repose sur l'identification de signes évocateurs, dont les plus

Diagnostic

Diagnostic

Le diagnostic en dermatologie repose sur une approche méthodique et pluridisciplinaire, intégrant l'anamnèse, l'examen clinique approfondi et une panoplie d'examens complémentaires, allant de l'histopathologie aux techniques d'immunofluorescence et de biologie moléculaire. Cette démarche vise à établir un diagnostic positif, à caractériser la maladie et à évaluer son pronostic, notamment dans le cadre des affections tumorales (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2011).

I. Approche Clinique Initiale

L'établissement d'un diagnostic dermatologique débute par une évaluation clinique rigoureuse, essentielle pour orienter les investigations ultérieures (Dermatologie, 2022).

A. Interrogatoire

L'interrogatoire est une étape fondamentale pour recueillir des informations pertinentes sur l'histoire de la maladie, les antécédents personnels et familiaux, les traitements en cours, et l'exposition à des facteurs environnementaux ou professionnels. Il permet de cerner le contexte d'apparition des lésions, leur évolution, les symptômes associés (prurit, douleur, brûlure) et l'impact sur la qualité de vie du patient (Dermatologie, 2022).

B. Examen Clinique

L'examen clinique doit être exhaustif, incluant l'inspection de l'ensemble du tégument, des phanères et des muqueuses. Il vise à caractériser les lésions élémentaires (macules, papules, nodules, bulles, pustules, squames, croûtes, érosions, ulcérations, etc.), leur topographie, leur arrangement et leur couleur. Des manœuvres spécifiques, telles que la diascopy, peuvent être utilisées pour évaluer la nature vasculaire d'une lésion (Dermatology Handbook, 2022). Pour certaines affections, des éléments cliniques spécifiques sont déterminants. Par exemple, le diagnostic positif d'une rosacée repose sur la reconnaissance de ses formes vasculaire, papulo-pustuleuse et hypertrophique, tandis que celui d'une dermatite séborrhéique est établi par les éléments cliniques positifs selon l'âge, la topographie des lésions et le terrain du patient (Dermatologie, 2022). De même, pour les hémangiomes du nourrisson, le diagnostic des formes typiques non compliquées est principalement clinique (Dermatologie, 2022).

II. Histopathologie Cutanée : Pilier du Diagnostic et du Pronostic

L'examen histopathologique de la biopsie cutanée est souvent l'examen complémentaire le plus crucial en dermatologie, permettant de confirmer la nature d'une lésion, d'établir un diagnostic précis et d'obtenir des informations pronostiques (Alikhan et Hocker, 2011; Dermatologie, 2022).

A. Rôle Général de l'Histopathologie

La dermatopathologie est une discipline à haut rendement diagnostique, résumant les caractéristiques histopathologiques essentielles de nombreuses entités et permettant de les différencier des diagnostics distracteurs potentiels (Alikhan et Hocker, 2011). Elle est indispensable pour l'affirmation diagnostique de nombreuses dermatoses, qu'elles soient tumorales, inflammatoires ou bulleuses.

B. Application dans les Tumeurs Mélaniques

Pour les tumeurs mélaniques, l'examen histologique est fondamental et permet plusieurs objectifs essentiels (Dermatologie, 2022):

- **Affirmer la nature mélanocytaire** : L'utilisation de marquages immunohistochimiques spécifiques tels que Melan-A, la protéine S100 et HMB45 est cruciale pour confirmer l'origine mélanocytaire des cellules tumorales.
- **Affirmer la malignité et déterminer le sous-type anatomoclinique** : L'histologie permet de distinguer les lésions bénignes des malignes et de classer le mélanome selon ses profils anatomocliniques. La classification anatomoclinique résume les différents types de mélanome en cinq grandes catégories :

* **Mélanomes avec phase d'extension horizontale initiale** :

* **Mélanome superficiel extensif (SSM)** : Le plus fréquent (60 à 70 % des cas), caractérisé par une croissance intra-épidermique horizontale avant une phase de croissance verticale dermique (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome de type Dubreuilh** : Représente environ 10 % des cas, siégeant sur les zones chroniquement photo-exposées, principalement le visage chez les sujets de plus de 60 ans, souvent associé à des signes de photovieillissement. Son évolution est typiquement horizontale pendant des mois ou des années avant de devenir invasif, formant un ou plusieurs nodules à croissance verticale (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome acral lentigineux (ALM)** : Constitue 2 à 5 % des cas, mais est majoritaire chez les sujets à peau pigmentée. Il se localise sur les paumes, les plantes, les bords latéraux des doigts et des orteils, ainsi que sur l'appareil unguéal (Dermatologie, 2022).

* **Mélanomes des muqueuses** : Affectent les muqueuses buccales et génitales (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome sans phase d'extension horizontale initiale** :

* **Mélanome nodulaire d'emblée** : Représente 10 à 20 % des cas, caractérisé par une évolution rapidement verticale invasive, parfois achromique (Dermatologie, 2022).

Il est important de noter qu'à indice de Breslow identique, toutes ces formes anatomocliniques ont un pronostic globalement comparable (Dermatologie, 2022).

• **Recueillir les paramètres histopronostiques fondamentaux** : L'épaisseur tumorale selon Breslow, la présence d'ulcération et l'index mitotique sont des facteurs pronostiques majeurs (Dermatologie, 2022).

• **Préciser le caractère complet ou non de l'exérèse** : Bien qu'une reprise chirurgicale soit systématiquement effectuée, l'histologie initiale renseigne sur la qualité de l'exérèse (Dermatologie, 2022).

• **Rechercher d'emblée une mutation de BRAF** : Selon l'avis de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), notamment pour les tumeurs épaisses de mauvais pronostic, la recherche de mutations de BRAF peut être réalisée sur la pièce opératoire (Dermatologie, 2022).

C. Application dans les Tumeurs Non-Mélaniques et Autres Affections

L'histologie est également essentielle pour le diagnostic de nombreuses autres tumeurs et dermatoses (Alikhan et Hocker, 2011):

• **Carcinome à cellules de Merkel** : Prolifération densément cellulaire de cellules fusiformes atypiques avec de larges zones de nécrose ("nécrose géographique") et un taux mitotique élevé. Il s'agit d'une masse dermique/sous-cutanée infiltrante composée de nappes de cellules basaloïdes uniformes avec un rapport N:C élevé et une chromatine finement mouchetée ("sel et poivre"), de nombreuses mitoses et cellules apoptotiques. Les colorations positives incluent CK20 (motif périnucléaire en point), neurofilaments (motif périnucléaire en point), chromogranine/synaptophysine, énolase neurone-spécifique, EMA et CD56. Les colorations négatives sont TTF-1, CK7, S-100 et CEA. Le principal diagnostic différentiel est le carcinome pulmonaire à petites cellules, qui est TTF-1+ et CK7+, et négatif pour CK20 et neurofilaments (absence de motif en point) (Alikhan et Hocker, 2011).

• **Neuroblastome** : Nodule dermique ou sous-cutané composé de petites cellules rondes et bleues. NSE+ et neurofilaments+ sont en faveur du neuroblastome par rapport à d'autres tumeurs à petites cellules rondes et bleues. La FISH pour n-Myc aide au diagnostic et est associée à un pronostic plus défavorable (Alikhan et Hocker, 2011).

• **Tumeur à cellules granuleuses** : Prolifération dermique de grandes cellules polygonales avec un cytoplasme abondant, éosinophile et granulaire, et un petit

Traitement

Traitement

La prise en charge thérapeutique en dermatologie est complexe et doit être individualisée en fonction de la pathologie, de sa sévérité, de ses localisations, de son retentissement sur la qualité de vie du patient, des comorbidités, des contre-indications potentielles et des antécédents du patient. Une approche collaborative entre le médecin traitant et le dermatologue est souvent nécessaire, notamment pour les maladies chroniques nécessitant une stratégie au long cours (Dermatologie, 2022). L'information du patient et son adhésion aux choix thérapeutiques sont des facteurs clés de succès.

I. Traitements du Psoriasis

Le traitement du psoriasis est une stratégie au long cours qui doit prendre en compte la gravité de l'atteinte

Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi en dermatologie constituent des piliers fondamentaux de la prise en charge des patients, qu'il s'agisse de pathologies chroniques, de néoplasies cutanées ou de l'administration de traitements systémiques. Cette démarche rigoureuse vise à optimiser l'efficacité thérapeutique, à prévenir et gérer les effets indésirables, et à détecter précocement les complications ou les récidives. L'élaboration de stratégies de surveillance doit s'appuyer sur des preuves scientifiques solides, allant des revues systématiques d'essais randomisés aux études observationnelles avec des effets dramatiques (Garbe et al., 2025).

I. Principes Généraux de la Surveillance en Dermatologie

La surveillance en dermat

Bibliographie

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Hauschild et al. - 2012 - Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma a multicentre, open-label, phase 3 randomised contro

• cutaneous_melanoma

• nmsc

• squamous

• Arits et al. - 2013 - Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superfici

• Kaufman et al. - 2016 - Avelumab in patients with chemotherapy-refractory metastatic Merkel cell carcinoma a multicentre, s

• Casey et al. - 2017 - FDA Approval Summary Sonidegib for Locally Advanced Basal Cell Carcinoma

• Weber et al. - 2017 - Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma

• Robert et al. - 2015 - Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation

• Hodi et al. - 2010 - Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• Gross et al. - 2022 - Neoadjuvant Cemiplimab for Stage II to IV Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma